

До повторного прийому гастроентеролога

Лада · 23.09.2026 · Мої нотатки для прийому

Що найбільше турбує

Скарги залишаються тими самими, що на попередньому прийомі: **частий біль у животі, особливо після їжі та після стероїдів**. Їсти стала більше, але досі дуже мало. Хочу, щоб її оглянули й пояснили, чи безпечно продовжувати лікування та відновлення харчування вдома, чи потрібні обстеження або стаціонар.

22.09 приблизно через 15 хвилин після Медролу почався біль у животі силою близько **5-6 із 10**. Вона їла приблизно за годину до таблетки. Цей біль відрізнявся від попереднього сильного болю під час нападів. Загалом після тяжких нападів живіт іноді болить кілька днів.

Харчування та вага

За моєю нинішньою оцінкою, майже місяць вона отримувала близько **100 ккал/день**. Тепер близько **800-900, можливо 1000 ккал/день**. Їсти заважають біль, слабкий апетит і страх реакцій. Останнім часом могла їсти крекери та кисломолочний сир, але раціон залишається дуже обмеженим.

Каші, рис і макарони давно уникає через погане самопочуття після них та попередні поради щодо кишківника. Розповідала також про червоні плями після деяких фруктів та овочів, зокрема моркви й помідорів. Точний зв'язок усіх симптомів з їжею нам незрозумілий.

Лікарі швидкої після огляду й розмови з нею сказали, що потрібно **їсти більше овочів, щоб посилити перистальтику**, і що при нинішньому харчуванні може знову бути непрохідність. Нам потрібні конкретні рекомендації: які продукти, у якому вигляді й кількості підходять саме їй.

Зріст 170 см. Раніше були виражені набряки обличчя, рук, ніг і живота. **Вага: 19.09 - 66,6 кг; 20.09 - 64,1 кг; 21.09 - 63,5 кг; 22.09 - 65 кг; сьогодні, 23.09 - 68 кг.**

Важливе з минулого

У березні 2026 року була госпіталізація через кишкову непрохідність, обійшлося без операції. У 2024-2026 роках перенесла кілька операцій через кісти яєчників; навесні 2026 були кровотечі, спайки з кишківником, маткою та сечовим міхуром і часткове видалення правого яєчника.

З дитинства пригадує виразку, гастрит або гастродуоденіт, точної назви не пам'ятає. Апетит погіршився ще приблизно минулої зими. Раніше також турбували нудота, здуття, чергування діареї та відсутності випорожнень.

Гастроентеролог: лікування та питання

Лада · 23.09.2026

Після попереднього прийому

14.09 призначали **Омез 20 мг зранку, Квамател 40 мг перед сном та Домрид SR 30 мг**. У рекомендаціях алерголога від 18.09 Квамател уже зазначений **по 20 мг двічі на день**. Прошу узгодити одну схему для живота й оцінити її ефект.

Медрол початково призначали **16 мг зранку + 8 мг увечері на 14-20.09**; ще 22.09 вона казала, що приймає його за призначенням. Потім швидко порадила припинити через проблеми з животом. До цього кілька тижнів періодично приймала дексаметазон та отримувала його під час невідкладної допомоги. **17.09 отримала Дексалгін і приймала німесулід; 18.09 також повідомляла про Німесил.**

Зараз важко з астмою, використовує небулайзер та іноді Вентолін, багато спить. Бувають сповільнене мислення й мовлення та нестійкість при ходьбі. Сьогодні також плануємо алерголога й ендокринолога.

Аналізи, які вже маємо

19.09: гемоглобін 112 г/л, MCV 78,9 фл; калій 4,06, магній 0,76, натрій 140, фосфор 1,43, кальцій загальний 2,31, глюкоза 5,6 ммоль/л. Креатинін 66 мкмоль/л, альбумін 36 г/л; АЛТ 17, АСТ 18, ГГТ 11, лужна фосфатаза 39 Од/л, білірубін 7,7 мкмоль/л.

14.09: феритин 31,5 нг/мл, насичення трансферину залізом 9,05%. **19.09:** ТТГ 5,833 мкМО/мл, вільний Т4 0,54 нг/дл.

Що хочу вирішити сьогодні

1. Причина болю й безпека лікування вдома. Прошу оглянути живіт та оцінити біль після їжі й ліків з урахуванням попередньої непрохідності та операцій. Чи потрібні сьогодні аналізи, обстеження живота, ендоскопія або стаціонар? Як полегшити біль, щоб вона могла їсти?

2. Конкретний план харчування. Що їй можна їсти зараз, якими порціями й як збільшувати кількість після майже місяця дуже малого харчування? Які овочі та спосіб приготування підходять з огляду на непрохідність і реакції на їжу? Чи потрібне спеціальне лікувальне харчування?

3. Контроль під час збільшення їжі. Чи потрібно зараз повторити фосфор, калій, магній, глюкозу та інші показники; як часто їх контролювати? Чи потрібні вітаміни, зокрема B1, або інша підтримка? Як оцінити швидку зміну ваги й набряки?

4. Подальше лікування й обстеження. Прошу визначити схему для шлунка з урахуванням лікування астми та болю після стероїдів. На минулому прийомі призначали аналізи калу на Н. рylogi, приховану кров і кальпротектин: що зараз пріоритетне та як підготуватися з урахуванням ліків? Чи потрібне лікування нестачі заліза, яке вона зможе переносити?